

## SINOPSIS DEL PROTOCOLO

### IN EXTREMIS - Ensayo MOSTE - Evaluación de la terapia en Ictus *minor*

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título y código</b>                             | Evaluación de la Revascularización Mecánica Aguda en el ictus por oclusión de gran vaso con síntomas Menores (NIHSS<6) en pacientes vistos bien por última vez < 24 horas<br><br><b>MinOr Stroke Therapy Evaluation: MOSTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Diseño del estudio</b>                          | Ensayo internacional, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado 1:1 a dos ramas paralelas, tratamiento abierto, y ciego en la evaluación de la respuesta ( <i>endpoint</i> ) (estudio "PROBE")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ciego</b>                                       | La asignación del tratamiento de este protocolo es abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivos del estudio</b>                       | <b>Objetivo Principal:</b><br>Demostrar la superioridad de la trombectomía mecánica (TM) asociada a la mejor terapia médica (MTM) comparada con la MTM sola para incrementar la independencia funcional en pacientes con oclusión de gran vaso (OGV) que presenten síntomas menores de ictus (NIHSS<6)<br><b>Objetivos Secundarios:</b><br>Evaluar la seguridad y la eficacia de la TM + MTM frente al MTM solo en pacientes con OGV que presenten síntomas menores de ictus (NIHSS<6).<br>En caso de deterioro neurológico en el brazo MTM, se permitirá terapia mecánica secundaria.<br><b>Objetivo de coste-efectividad:</b><br>Evaluación coste-efectividad, en los hospitales Franceses, de la TM en el subgrupo de pacientes con NIHSS 0-5 frente a la terapia médica sola en ictus agudos por oclusión de gran vaso |
| <b>Tamaño de la muestra y Duración del Estudio</b> | Está previsto reclutar un máximo de 824 pacientes en el ensayo, 412 en el brazo de tratamiento y 412 en el brazo control.<br><br>Periodo de reclutamiento: aproximadamente 96 meses, hasta el 30/04/2027<br><br>Participación de los pacientes: 90 días (±14) desde la aleatorización<br><br>Duración total del estudio: aproximadamente 99 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Número previsto de centros /Países</b>          | Hasta 41 centros en todo el mundo en los países participantes (Europa, E.E.U.U.); cada centro participante se compromete a reclutar entre 25 y 40 pacientes en Europa. Los centros de Estados Unidos se comprometen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | reclutar de 10 a 14 pacientes. Participarán hasta 10 centros en Estados Unidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reclutamiento de pacientes (estatus)</b> | El reclutamiento de pacientes estará monitorizado a través de un sistema electrónico de captura de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aleatorización</b>                       | <p>Los sujetos serán aleatorizados 1:1 a trombectomía mecánica más el mejor tratamiento médico o al mejor tratamiento médico solo</p> <p>La estratificación se realizará por: Edad &lt;70 vs ≥ 70 años, localización de la oclusión (ACI vs ACM-M1 o M1-M2 con o sin lesión cervical (Tándem), fibrinólisis IV, e inicio de síntomas o Última Vez Visto Bien 0-4,5 vs &gt;4,5-23 horas</p> <p><i>Reclutamiento</i> en este estudio está definido como el momento en el que se completa el proceso de aleatorización y el sujeto se asigna a una rama del estudio (tiempo cero)</p>                                                                          |
| <b>Análisis de población</b>                | <p>Análisis por intención de tratar (objetivo principal y secundarios)</p> <p>Están previstos 2 análisis intermedios para medir eficacia y futilidad.</p> <p>Se realizarán análisis separados para excluir a cualquier sujeto tratado fuera de las pautas de la FDA para el uso de terapia trombolítica y la ruta de acceso para dispositivos aprobados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivos del estudio</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Parámetro de eficacia</b>                | Puntuación de la Escala Rankin Modificada a los 90 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo Principal de Eficacia</b>       | Tasa de pacientes que a los 90 días presenten excelentes resultados definidos como mRS 0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivos Secundarios de Eficacia</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasa de pacientes con resultado favorable a los 90 días definido como mRS 0-2</li> <li>2. Tasa de pacientes con resultado funcional perfecto a los 90 días definido como mRS 0</li> <li>3. Calidad de vida a los 90 días evaluada con la escala EuroQol 5D-5L</li> <li>4. Función cognitiva a los 90 días de acuerdo con la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) y la prueba <i>Trail Making Test A</i> y B, y la prueba <i>STROOP Victoria Test</i></li> <li>5. Cambio en el NIHSS a las 24 (-6/+12) horas tras aleatorización</li> <li>6. Tasa de pacientes que requieren trombectomía secundaria</li> </ol> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>7. El número de pacientes con mRS 0-1 a los 90 días en el brazo de tratamiento frente al número de pacientes con mRS 0-1 a los 90 días en el brazo control que se sometieron a TM secundaria</p> <p>8. Volumen del infarto a las 24 (-6/+12) horas desde la aleatorización, por <i>MRI T2/FLAIR</i> cerebral o <i>CT</i></p> <p>9. Tasa de puntuación TICI 2b/3 evaluada por angiografía en el brazo de tratamiento y en el brazo de control tratado con trombectomía secundaria</p> <p>10. Tasa de revascularización a las 24(-6/+12) horas en MRA o CTA</p>                                     |
| <b>Objetivos de coste-efectividad del estudio</b> | Ratio de coste efectividad Incremental (ICER): diferencia entre los costes totales del tratamiento dividido por la diferencia en el resultado (mRS $\leq 2$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resultados de seguridad</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo principal de seguridad</b>            | Incidencia de mortalidad por cualquier causa a los 90 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo secundario de seguridad</b>           | <p>Incidencia de hemorragia intracerebral sintomática según HEIDELBERG en la imagen 24 (-6 /+12) horas tras la aleatorización</p> <p>NIHSS <math>\geq 10</math> puntos entre el ingreso y la visita D5/D7 (o alta, si esta ocurre antes)</p> <p>Incidencia de acontecimientos adversos relacionados con el procedimiento / dispositivo (en pacientes tratados con tratamiento mecánico, en el grupo TM o en el grupo MTM, en caso de trombectomía secundaria)</p>                                                                                                                                    |
| <b>Población de Estudio</b>                       | <p>Los pacientes que cumplan con todos los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión (tanto generales como de imagen) serán elegibles para participar en el estudio)</p> <p>Todos los pacientes considerados para participar habrán recibido tratamiento estándar para el tratamiento del ictus antes de la evaluación de elegibilidad, incluida la administración de terapia trombolítica, para pacientes que cumplan con las pautas de la institución para dichos tratamientos. Dicho tratamiento no se retrasará debido a la evaluación de elegibilidad para el estudio.</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterios<br/>Generales de<br/>Inclusión</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El paciente es <math>\geq 18</math> años en el momento de la inclusión (no hay límite máximo de edad)</li><li>2. Signos clínicos consistentes en un ictus isquémico agudo con hora a la que ha sido visto bien por última vez (TLKW) <math>\leq 23h^1</math> hasta aleatorización</li><li>3. NIHSS 0-5 en el momento de la aleatorización con déficit incapacitante que impediría a un paciente realizar actividades básicas de la vida diaria (bañarse, deambular, ir al baño, higiene y comer) o regresar al mismo trabajo</li><li>4. Puntuación ASPECT <math>\geq 6</math> en TC sin contraste o DWI-MRI</li><li>5. Ictus isquémico confirmado con imagen cerebral o imagen normal con sospecha de accidente cerebrovascular isquémico</li><li>6. Oclusión de gran vaso intracraneal de la circulación anterior en CTA o MRA (ACI, M1, M1-M2) con o sin lesión cervical (Tándem) en el momento de la aleatorización. El segmento ACM - M1 se define como la primera rama de la ACI intracraneal que discurre horizontalmente desde su punto de ramificación fuera de la ACI a través de la Cisura de Silvio hasta la primera bifurcación distal a las arterias lenticuloestriadas, en la Cisura de Silvio. La oclusión M1-M2 se considera que representa una oclusión del segmento M1 distal y se define operativamente como una oclusión total del segmento M2 (definido como las porciones de la ACM distales a la primera bifurcación o trifurcación, pero anteriores a la segunda bifurcación) y sospecha de cualquier afectación del segmento M1.</li><li>7. Para los pacientes "Drip and Ship": realizar nueva imagen en el centro que aleatoriza al paciente si la primera imagen se realiza <math>&gt; 1</math> hora antes de la aleatorización.</li><li>8. El paciente o el representante del paciente ha recibido información sobre el estudio y ha firmado y fechado el Formulario de Consentimiento Informado apropiado</li><li>9. Posibilidad prevista de iniciar el procedimiento (acceso arterial) dentro de los 60 minutos posteriores a la aleatorización</li><li>10. mRS <math>\leq 1</math> previa al ictus</li><li>11. Para los pacientes para quienes está indicada la terapia trombolítica, como t-PA IV, independientemente del grado de discapacidad, dicho tratamiento se inicia lo antes posible y dentro de las pautas clínicas aceptadas,</li></ol> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> El tratamiento debe iniciarse dentro de las 24 horas desde TLKW (máximo 60 minutos desde el momento de la aleatorización hasta el tratamiento)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | medidas desde el inicio de los síntomas del ictus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterios Generales de Exclusión</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imposibilidad prevista de iniciar el procedimiento (acceso arterial) dentro de los 60 minutos posteriores a la aleatorización</li> <li>2. Ausencia conocida de acceso vascular</li> <li>3. Alergia potencialmente mortal al contraste o a productos endovasculares</li> <li>4. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia al momento del ingreso</li> <li>5. Paciente que presenta comorbilidades severas o fatales o esperanza de vida menor de 6 meses ya que probablemente interfiera con una mejoría o un seguimiento o que hará que el procedimiento beneficie poco al paciente</li> <li>6. Paciente incapaz de estar presente o disponible durante el seguimiento</li> <li>7. Enfermedad neurológica o psiquiátrica preexistente que podría confundir las evaluaciones neurológicas o funcionales</li> <li>8. Evidencia de recanalización del vaso antes de la aleatorización</li> <li>9. Convulsiones al inicio del ictus si hace que el diagnóstico del ictus sea dudoso y no permita obtener una evaluación del NIHSS basal precisa</li> <li>10. Participación actual en otro estudio de investigación de drogas</li> <li>11. Sospecha de disección aórtica basada en la historia médica previa , evaluación clínica y/o en la imagen</li> <li>12. Pacientes ancianos bajo tutela</li> <li>13. Niveles de glucosa &lt; 50 mg/dL o &gt; 400 mg/dL</li> <li>14. Niveles de creatinina Cr &gt; 4.0 mg/dL, a menos que el paciente esté en diálisis</li> <li>15. Recuento de plaquetas &lt; 50000/uL</li> <li>16. INR &gt; 3.0 o PTT &gt; 3 veces el límite superior de lo normal (LSN)</li> </ol> |
| <b>Criterios de exclusión de imagen</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oclusión cervical aislada de la ACI proximal</li> <li>2. Evidencia de hemorragia intracraneal en CT / MRI</li> <li>3. Tortuosidad excesiva de vasos cervicales en CTA / MRA que probablemente resulte en un acceso inestable de la plataforma</li> <li>4. Alta sospecha de estenosis intracraneal subyacente en CTA / MRA</li> <li>5. Sospecha de enfermedad vascular cerebral (por ejemplo, vasculitis) basada en la historia médica previa y CTA / MRA</li> <li>6. Supuesto émbolo calcificado o estenosis intracraneal descompensada</li> <li>7. Stent intracraneal implantado en el mismo territorio vascular que impediría</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>el despliegue / retirada segura del dispositivo <i>stent retriever</i></p> <p>8. Oclusiones en múltiples territorios vasculares (por ejemplo: circulación anterior bilateral, o circulación anterior / sistema vertebrobasilar) confirmadas en CTA / MRA</p> <p>Efecto de masa significativo con desplazamiento de la línea media confirmado por CT / MRI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Retirada de estudio</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muerte</li> <li>2. Retirada del consentimiento</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tratamiento endovascular</b> | <p>La TM en el brazo experimental se puede realizar con cualquier dispositivo de trombectomía (con marcado CE o con la autorización de la FDA para revascularización con código NRY) que generalmente se utilice en el centro del estudio e incluido en la lista de dispositivos aprobados para este estudio. Cabe señalar, que la FDA solo ha autorizado el uso del dispositivo de revascularización Trevo Retriever y Solitaire en el tratamiento del ictus más allá de las seis horas desde el inicio de los síntomas para reducir la discapacidad en ciertos pacientes con ictus agudo.</p> <p>El intervencionista puede elegir qué <i>stent retriever</i> o catéter de aspiración utilizar, dependiendo de las consideraciones anatómicas y preferencias personales</p> <p>En los casos en los que se use un <i>stent retriever</i>, el uso de un catéter guía balón es un pre-requisito técnico.</p> <p>Se recomienda el uso de material adicional como catéter de aspiración, en combinación con <i>stent retrievers</i></p> <p>No se define ninguna limitación en el número de pases durante el procedimiento; sin embargo, <u>se recomienda no exceder 3 pases por dispositivo o tres (3) intentos de retirada en un único vaso.</u></p> <p>Para los sujetos asignados al azar al brazo TM más MTM, el inicio del tratamiento se define como el momento del acceso arterial (por ejemplo, punción femoral).</p> <p>El acceso se obtendrá mediante un abordaje transfemoral para este estudio siempre que sea posible; Si el acceso femoral no es posible, los detalles se documentarán en el cuaderno de recogida de datos.</p> <p>La anestesia apropiada debe administrarse y lograrse lo antes posible, permitiendo el inicio del procedimiento endovascular dentro de los 60 minutos</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>tras la aleatorización</p> <p>Para los pacientes aleatorizados al brazo de Mejor Tratamiento Médico, la <b>tombectomía secundaria se puede realizar dentro de las 24 horas posteriores a la aleatorización solo si se produce un deterioro neurológico</b>. Esto se define como un empeoramiento en el NIHSS de <math>\geq 4</math> puntos en comparación con el valor inicial o alcanzar NIHSS de <math>\geq 6</math>, o si hay un deterioro clínico que requiera intervención según el médico tratante.</p> <p>Para calificar para dicha trombectomía "secundaria", el paciente se someterá a un proceso de reevaluación para garantizar la seguridad del paciente. Se realizará una tomografía computarizada sin contraste para detectar hemorragia u otras causas no isquémicas de progresión del ictus que descalificarían al paciente de dicho tratamiento. Se necesita una puntuación ASPECT <math>&gt; 6</math> en la TC de reevaluación para cumplir con los requisitos de elegibilidad.</p> <p>En los pacientes en los que el deterioro ocurre más allá de las 24 horas de aleatorización deben ser tratados de acuerdo con los protocolos locales de atención. El cambio en el valor de NIHSS y el tratamiento elegido deben ser registrados en el CRDe por un equipo investigador capacitado certificado</p> <p>Antes del inicio del procedimiento endovascular, la puntuación TICI modificada debe evaluarse y registrarse</p> <p>La fase venosa tardía debe incluirse en todas las adquisiciones de los angiogramas</p> <p>Embolización en un Nuevo Territorio (ENT): cualquier infarto nuevo en la neuro-imagen a las 24 (-6/+12) horas comparado con las imágenes basales, independientemente donde se realice el cateterismo</p> <p>Medicación concomitante en pacientes con TEV:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No se permite el uso de líticos IA (desviación del protocolo) durante el procedimiento y hasta después de completar el seguimiento por imagen</li><li>• Se puede usar anticoagulante sistémico con heparina durante el procedimiento, pero no debe exceder un total de 3.000 unidades de bolo de heparina seguido de una infusión de 500 unidades/hora durante la duración del procedimiento</li><li>• El uso prudente de agentes anti-vasoespasma está permitido durante el procedimiento</li><li>• Para los pacientes con stent carotídeo, los fármacos antiplaquetarios están</li></ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | permitidos a discreción del investigador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mejor Tratamiento Médico</b>               | <p>La administración de medicación queda a criterio del médico tratante</p> <p>Los pacientes tratados previamente con anticoagulantes y/o agentes antiplaquetarios, pueden continuar este régimen si, según la opinión del investigador, los beneficios de la terapia continuada superan los riesgos de un posible deterioro neurológico relacionado con hemorragia</p> <p>Todos los pacientes incluidos en este estudio deben ser tratados médicamente de acuerdo con las pautas actuales de las guías AHA/ASA o las guías de la <i>European Stroke Organization</i></p> <p>Se realizarán análisis de datos separados para cualquier caso en el que la terapia trombolítica se use más allá del período de tres horas aprobado por la FDA desde el inicio de los síntomas, y dichos casos se omitirán del análisis de datos regulatorios.</p> |
| <b>Retirada y Sustitución de pacientes</b>    | <p>El participante puede retirarse del estudio en cualquier momento, con o sin razón y sin perjuicio de tratamiento adicional o atención médica. Los pacientes también pueden retirarse del estudio a discreción del IP o el Promotor por razones de seguridad o administrativas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Calendario de seguimiento por paciente</b> | <p>Todos los tiempos de seguimiento son relativos al tiempo de aleatorización (tiempo cero)</p> <p>Visita 1: basal, que contiene todos los datos básicos requeridos</p> <p>Visita 2: 24 (-6/+12) horas, NIHSS y MRI/MRA o CT/CTA. La hemorragia y el volumen del infarto durante el seguimiento, se medirá mediante MRI T2/Flair o CT. Cuestionario <i>Short IQCode</i></p> <p>Visita 3: a los 5-7 días (si el paciente sigue ingresado) o alta, lo que ocurra antes: evaluación NIHSS</p> <p>Visita 4: a los 90 (<math>\pm 14</math>) días, mRS ciego, EuroQol 5D-5L, QALY, MoCA, evaluaciones del Trail Making A y B, y <i>STROOP Victoria Test (centros franceses)</i>.</p>                                                                                                                                                                 |